تعرض مؤسسات صحية كثيرة على أطبائها أرقام أدائهم.

وفي مراجعة لتجارب كثيرة، اتبع من تلقّوا الأرقام ما توصي به الأدلة أكثر ممن لم يتلقّوها، بفرق نحو 6 نقاط مئوية في المتوسط.

لكن الأثر تفاوت كثيرًا، كما تبيّن خمس دراسات نُشرت بين عامي 2021 و2026.

← اسحب للمتابعة

الفكرة

ما التدقيق والتغذية الراجعة؟

هو أن يُقاس أداء الطبيب أو الفريق مدة محددة، ثم تُعرض عليه النتائج.

والنقطة المئوية هي الفرق بين نسبتين: فالانتقال من 50% إلى 56% زيادة بست نقاط مئوية.

وفي التجربة العشوائية يُقسَم المشاركون بالقرعة إلى مجموعتين، ثم تُقارَن نتائجهما.

جمعت كوكرين 292 تجربة عشوائية

وكوكرين شبكة دولية من الباحثين تجمع الدراسات عن سؤال واحد وتلخّص نتائجها.

6.2

هو متوسط ما زاد به اتباع توصيات الأدلة، بالنقاط المئوية، في 177 تجربة قارنت من تلقّوا الأرقام بمن لم يتلقّوها.

2.7

نقطة مئوية هى الحد الذى لم يتجاوزه التحسن في نصف النتائج. وفي ربعها على الأقل لم يحدث تحسن. وهذا الرقم محسوب بطريقة أخرى، فلا يُقارَن بالمتوسط مباشرة.

وكان التحسن أكبر عند الأطباء الذين بدؤوا بأداء ضعيف.

وصف المضادات الحيوية

من تلقّوا أرقامهم من أطباء العيادات وصفوا مضادات حيوية أقل

11%

هي نسبة انخفاض كمية المضادات الحيوية عند من تلقّوا الأرقام، في 21 تجربة.

23%

هي نسبة انخفاض عدد المرات التي بدأ فيها الأطباء مضادًا حيويًا لا حاجة إليه، في 16 تجربة.

والمقصود أطباء الرعاية الأولية، أي أطباء العيادات والمراكز الصحية التي يقصدها المريض أولًا. والنسبتان محسوبتان قياسًا إلى ما فعله الأطباء الذين لم يتلقّوا الأرقام، وليستا نقاطًا مئوية، فلا تُقارنان بالنقاط الست في الشريحة السابقة.

Xu et al., Clin Infect Dis, 2025

TAMAYUZ 10X

نتائج متباينة

وفي ثلاث تجارب أخرى، لم تتحسن كل المقاييس

في أونتاريو بكندا، قُسّم بالقرعة 833 طبيبًا يفحصون الأمعاء بمنظار إلى مجموعتين، وتلقّت إحداهما تقريرًا عن أدائها. فارتفعت في المجموعتين بقدر متقارب نسبة الفحوص التي استُؤصلت فيها زوائد لحمية. لكن الأضعف أداءً ممن تلقّوا التقرير تحسّنوا أكثر من نظرائهم الذين لم يتلقّوه.

وفي سبعة أقسام لطوارئ الأطفال، تلقّى المسؤولون تقريرًا شهريًا عن أداء أقسامهم. فتحسّن تسجيل العلامات الحيوية للطفل، كالحرارة والنبض، وساءت في الفترة نفسها سرعة الخدمة.

وفي 201 مركز لجراحة أورام المثانة، تحسّن تسجيل المعلومات الجراحية في المراكز التي تلقّت التقارير، ولم يختلف معدل عودة الورم بين المراكز التي تلقّتها والتي لم تتلقّها.

متى كان الأثر أكبر؟

كان الأثر أكبر حين خصّت الأرقام الطبيب نفسه، لا فريقه أو مؤسسته

وكان أكبر حين قورن أداؤه بأفضل زملائه أو بمستوى محدد.

وكان أكبر حين عرض الأرقام عليه شخص من مكان العمل يعرفه من قبل.

وكان أكبر حين وُضعت مع الأرقام خطة فيها خطوات محددة للتحسين.

جاءت أكثر هذه النتائج من مقارنة التجارب بعضها ببعض، وقال الباحثون إنها تحتاج إلى تأكيد.

Ivers et al., Cochrane, 2026

ما يستنتجه الكاتب من الدراسات

ما الذي يستطيع القائد فعله؟

1

يختار مؤشرًا مهمًا ما زال الأداء فيه بعيدًا عن المطلوب.

2

ويعرض على كل موظف أرقامه هو، ويرتّب أن يناقشها معه شخص يعرفه من مكان العمل، ويرفق بها خطة محددة.

3

ويراقب مقاييس أخرى قد تسوء، لا المقياس المستهدف وحده.

هذه ثلاث من ست خطوات في المقال، استنتجها الكاتب من الدراسات، ولم تختبرها أي دراسة مجتمعةً.

> **بعد ثلاث سنوات، أتريد أن تبقى تقارير الأداء في مؤسستك أوراقًا تُنسى، أم أن يراجع كل موظف أرقامه مع زميل يعرفه ويختاراً خطوة لتحسينها؟**

حدود هذه الأدلة

في 39% من تجارب مراجعة كوكرين، كان في التصميم أو التنفيذ ما قد يجعل النتيجة غير دقيقة، ويسمّي الباحثون ذلك خطرًا مرتفعًا للتحيز.

وتقيس المراجعة ما يفعله العاملون الصحيون، لا صحة المرضى.

ولم يذكر ملخص أيٍّ من الدراسات الخمس تجربة في دولة عربية، ولم تختبر أيٌّ منها الفكرة خارج الرعاية الصحية، فنفعها في القطاعات الأخرى استنتاج من الكاتب لم يُختبر بعد.

تنويه تحريري: الآراء والتحليلات الواردة في هذا المقال تمثل رأي الكاتب وتحليله المهني استنادًا إلى المصادر المشار إليها، ولا تمثل بالضرورة المواقف الرسمية للجهات المذكورة. وللاطلاع على المعلومات والمراجع الأصلية والكاملة والأحدث، يُرجى الرجوع مباشرة إلى المصادر الأصلية والوثائق الرسمية الواردة في قائمة المراجع.

[1] Ivers, N., et al. (2026). Audit and feedback: effects on professional practice. *Cochrane Database Syst Rev*, CD000259.

[2] Xu, A. X. T., et al. (2025). Audit and feedback interventions for antibiotic prescribing in primary care. *Clin Infect Dis*, 80(2), 253–262.

[3] Tinmouth, J., et al. (2021). A pragmatic RCT of an endoscopist audit and feedback report for colonoscopy. *Am J Gastroenterol*, 116(10), 2042–2051.

[4] Chamberlain, J. M., et al. (2025). Audit and feedback on pediatric emergency department performance measures. *Hosp Pediatr*, 15(11), 901–910.

[5] Gallagher, K., et al. (2026). RESECT: a randomised controlled trial of audit and feedback in bladder cancer surgery. *Eur Urol*, 89(4), 355–365.

المقال الكامل: tamayuz10x.com/article-oe-evidence-audit-and-feedback.html